Kritériá Rome pri poruchách interakcie črevo–mozog (DGBI) a kedy „ďalej testovať“ pri IBS: poučenie zo štúdie na medikoch

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 03.09.2026



Ilustračná scéna. Ak kritériá sedia a varovné príznaky chýbajú, ďalšie testovanie spravidla neprinesie nový poznatok – len odklad diagnózy.

Kritériá Rome umožňujú stanoviť syndróm dráždivého čreva ako pozitívnu, symptómovú diagnózu, ak chýbajú varovné príznaky. Multicentrická štúdia na medikoch v Latinskej Amerike ukázala, že samotná znalosť týchto kritérií nestačí na racionálne testovanie. Pre nefrológiu je to poučné tam, kde sú gastrointestinálne ťažkosti časté a nešpecifické.

Funkčné gastrointestinálne ťažkosti – najmä syndróm dráždivého čreva (IBS) – sa v praxi ešte stále často uzatvárajú až po „vylúčení všetkého ostatného“. Takýto postup predlžuje cestu k liečbe, zvyšuje úzkosť pacienta a zbytočne zaťažuje diagnostiku. Kritériá Rome tento model zámerne otáčajú: pri typickom obraze a absencii varovných príznakov má ísť o **pozitívnu klinickú diagnózu**, nie o diagnózu vylúčením.

To neznamená, že kritériá Rome „zakazujú“ vyšetrenia. Umožňujú stanoviť diagnózu na základe symptómov a cieliť ďalšie testovanie podľa varovných príznakov a fenotypu. Rozdiel je v tom, či laboratórium, zobrazovanie a endoskopia slúžia ako *cielený krok*, alebo ako *rituál vylučovania* – teda preto, lebo diagnóza bez nich „neplatí“.

V nefrologickej praxi má toto rozlíšenie skromný, ale praktický význam. Pacienti s chronickou chorobou obličiek (CKD) a multimorbiditou majú časté nešpecifické gastrointestinálne ťažkosti. Riziko diagnostickej eskalácie bez jasných alarmov je v bežnej praxi vysoké – a rovnako nebezpečné je bagatelizovať skutočný varovný príznak, napríklad anémiu z nedostatku železa, ako „iba CKD“.

Čo sú DGBI a čo znamenajú kritériá Rome

Poruchy interakcie črevo–mozog (DGBI, z angl. *disorders of gut–brain interaction*) sú chronické alebo recidivujúce gastrointestinálne ťažkosti, pri ktorých ide o ľubovoľnú kombináciu poruchy motility, viscerálnej hypersenzitivity, zmien slizničnej a imunitnej funkcie, mikrobioty a/alebo spracovania signálov v centrálnom

nervovom systéme. Medzi najznámejšie DGBI patria IBS, funkčná dyspepsia a chronická zápcha. Starší pojem „funkčné gastrointestinálne poruchy“ v aktuálnom rámci Rome Foundation ustupuje označeniu DGBI.

Kritériá Rome sú medzinárodný konsenzus Rome Foundation. Štúdia, o ktorú sa tento článok opiera, používala vinety podľa **Rome IV** (2016). Rámec **Rome V** (2026) pripravilo podľa nadácie viac než 140 odborníkov z 27 krajín; pri IBS vracia do kritérií aj diskomfort popri bolesti a znižuje prah frekvencie na tri dni v mesiaci namiesto týždenného pravidla Rome IV. Tento údaj o počte expertov patrí k Rome V, nie k starším edíciám.

Rome IV pri IBS vyžaduje rekurentnú bolesť brucha v priemere aspoň jeden deň v týždni za posledné tri mesiace, spojenú s dvoma alebo viacerými z týchto znakov: súvis s defekáciou, zmena frekvencie stolice, zmena formy stolice. Príznaky majú trvať aspoň šesť mesiacov pred diagnózou. Rome V oddeľuje aj *klinické* a *výskumné* kritériá: v praxi má ísť o použiteľný úsudok, vo výskume o prísnejšiu reprodukovateľnosť.

Cieľom je posun od čisto „diagnosis of exclusion“ k pozitívnej diagnóze. Randomizovaná štúdia Begtrupovej a spolupracovníkov už v roku 2013 ukázala, že pozitívna diagnostická stratégia pri IBS nie je horšia ako stratégia vylučovania. To však nie je dôkaz, že žiadne cielené testy netreba – ide o to, nebudovať diagnózu na nekonečnom došetrení.

Štúdia na medikoch: znalosť nestačí na zdržanlivosť

Linares a spolupracovníci v *Neurogastroenterology & Motility* (máj 2026) uverejnili multicentrickú prierezovú štúdiu *Knowledge Does Not Translate Into Diagnostic Restraint*. Zúčastnilo sa jej **238 medikov v klinických ročníkoch** (po aspoň jednom roku stáží) zo **45 univerzít v 14 krajinách Latinskej Ameriky**. Priemerný vek bol 24,3 roka (SD 4,1), ženy tvorili 63,4 %. Išlo o dobrovoľný anonymný výber, nie o náhodnú vzorku; zber prebiehal od januára do marca 2026, teda ešte pred zverejnením Rome V.

Nástroj mal päť oblastí: demografické údaje, výučbu DGBI, teoretické znalosti kritérií Rome, zaradenie varovných príznakov a klinické uvažovanie na postupných vinietách. Dospelá vineta opisovala **28-ročnú ženu spĺňajúcu Rome IV pre IBS bez varovných príznakov**. Potom sa tá istá kazuistika predložila v troch etapách: úvod; vyššia intenzita bolesti bez nových alarmov; kontrola po dvoch týždňoch s normálnymi laboratórnymi výsledkami. Nakoniec sa rovnaký obraz preložil do 7-ročného dieťaťa.

Ukazovateľ	Výsledok
Špecifická výučba DGBI	74 % (176/238)
Počuli o kritériách Rome	69 % (165/238)
IBS správne definovali ako pozitívnu diagnózu, nie ako diagnózu vylúčením	46 %
Dospelú vinetu hodnotili ako pravdepodobne funkčnú	76 %
Aj tak objednali úvodné diagnostické testy	70 %
Eskalácia testov pri silnejšej bolesti bez nových alarmov	61 %
Ďalšie testy aj po normálnych laboratórnych výsledkoch	53 %
Úvodné testy pri vysokých oproti nižším teoretickým znalostiam	68 % oproti 83 % (p = 0,010)
Vysoký zložený klinický výkon	15 %
Vysoké znalosti, ale slabé klinické uvažovanie	21 %

Najčastejšie požadované vyšetrenia zahŕňali krvný obraz, zápalové markery, celiakálnu sérológiu, fekálny kalprotektín, železo, ultrasonografiu brucha, CT aj kolonoskopiu. Po normálnych laboratórnych výsledkoch ostávali v hre najmä kolonoskopia a CT. „Vysoké diagnostické nadužívanie“ (testovanie v aspoň dvoch etapách vinety) malo 66 % účastníkov.

Pri pediatrickej vinete bez varovných príznakov označilo 46 % medikov obraz za nepravdepodobne funkčný. Testovanie ostalo vysoké. To podporuje záver autorov: vylučovací reflex sa formuje už v pregraduálnej príprave, nielen v praxi špecialistov.

Obmedzenia sú zrejmé. Išlo o vinety, nie o pozorované ambulancie; o jeden IBS obraz, nie o celé spektrum DGBI; o dobrovoľný výber v latinskoamerických školách. Prenos do slovenského pregraduálneho vzdelávania preto nie je automatický – vzorec „viem kritériá, ale aj tak testujem“ je však dostatočne všeobecný na to, aby stál za pozornosť.

Varovné príznaky: čo študenti mýlili

V nástroji štúdie boli varovné príznaky zvolené vopred podľa Rome IV a súčasných odporúčaní pre IBS: **gastrointestinálne krvácanie, neúmyselný úbytok hmotnosti, porucha rastu, recidivujúca horúčka, nočná hnačka a rodinná anamnéza zápalových chorôb čreva (IBD)**. Ako nealarmové boli zadané typické funkčné znaky, napríklad bolesť brucha s úľavou po stolici, a normálne laboratórium pri inak Rome-konzistentnom obraze.

Príznak	V nástroji štúdie	Zaradenie medikmi
Neúmyselný úbytok hmotnosti	varovný	správne 90 %
Viditeľné rektálne krvácanie	varovný	správne 85 %
Porucha rastu	varovný	správne 76 %
Rodinná anamnéza IBD	varovný	správne 70 %
Recidivujúca horúčka	varovný	správne 69 %
Nočná hnačka	varovný	správne len 45 %
Bolesť brucha s úľavou po stolici	nie je varovný	30 % ho nesprávne označilo za alarm

Približne tretina respondentov nesprávne zaradila aspoň jeden definičný funkčný príznak ako varovný. To je klinicky dôležité: ak sa typický znak IBS prečíta ako alarm, spustí sa vylučovacia kaskáda aj tam, kde Rome IV žiada pozitívnu diagnózu. V bežných odporúčaniach sa k štúdiovému zoznamu zvyčajne pridávajú aj **anémia, neskorší vek vzniku ťažkostí a rodinná anamnéza kolorektálneho karcinómu**. Štúdia ich ako samostatné položky nástroja neuvádzala; v ambulancii ich však treba hľadať.

Kedy má zmysel testovať ďalej

Tu treba oddeliť dva plány, ktoré sa v sekundárnych textoch často zlejú. Štúdia na medikoch hodnotila *akékoľvek* objednanie testu vo vinete bez alarmov ako odklon od diagnostickej zdržanlivosti – vrátane krvného obrazu a kalprotektínu. Odporúčanie ACG z roku 2021 však pri IBS s hnačkou **cielené** neinvazívne testy naopak navrhuje. Poučenie teda nie je „nerobiť nič“, ale „nerobiť z IBS diagnózu vylúčením a neeskalovať po už normálnych výsledkoch“.

Nasledujúci prehľad treba čítať ako orientáciu podľa ACG 2021 a verejných materiálov Rome Foundation, **prispôsobenú miestnej praxi**. Nie je to zoznam vyšetrení „vždy a pre každého“.

Situácia	Čo zvážiť	Čo nie je automaticky indikované
Typický IBS bez varovných príznakov	Pozitívna klinická diagnóza; pri hnačkovom fenotype celiakálna sérológia a fekálny kalprotektín, podľa kontextu aj KO a CRP	Paušálne CT, „kompletné vylúčenie“ a opakované testy bez novej indície
Kalprotektín pozitívny pri hnačke	Došetrenie v smere IBD, zvyčajne kolonoskopia	Ignorovanie nálezu len preto, že „ide o IBS“
Varovné príznaky (krvácanie, úbytok hmotnosti, nočná hnačka, horúčka, závažná rodinná anamnéza, anémia)	Cielené laboratórium a endoskopia podľa nálezu	Uzatvorenie IBS pred došetrením alarmu
Vek skríningu kolorektálneho karcinómu bez predchádzajúceho vyšetrenia	Kolonoskopia alebo iný validovaný skríning podľa aktuálnej miestnej praxe	Rutinná kolonoskopia u mladších bez alarmov. ACG 2021 ju neodporúča pod 45 rokov; v slovenskom organizovanom skríningu je hranica zvyčajne 50 rokov
Normálne laboratórium, žiadne nové alarmy, len silnejšie symptómy	Revízia diagnózy DGBI, liečba, sledovanie	Eskalácia na CT alebo kolonoskopiu „pre istotu“ – presne tento vzorec štúdia zachytila u 53 % medikov

Inými slovami: kritériá Rome **neumožňujú vyhnúť sa všetkému došetreniu**. Umožňujú stanoviť pozitívnu diagnózu a testovať cielene, nie plošne. Znalosť kritérií sama o sebe racionálne testovanie negarantuje.

Čo z toho plynie pre vzdelávanie – a pre nefrológiu

Autori štúdie to formulujú presne: rozpor medzi princípmi Rome a aplikovaným uvažovaním vzniká už počas pregraduálnej prípravy. Teoretická znalosť súvisí s nižším úvodným testovaním, ale nadužívanie ostáva časté aj u tých, ktorí kritériá ovládajú. Didaktická hodina nestačí. Sľubnejší signál dávala kazuistická výučba. Vzdelávanie by malo učiť odlíšiť varovný príznak od definičného znaku IBS, pomenovať pozitívnu diagnózu nahlas a skúšať nielen úplný diferenciál, ale aj primeranú zdržanlivosť.

Pre nefrológiu z toho nevyplýva, že by sme IBS diagnostikovali namiesto gastroenterológa. Záver je skromnejší. Gastrointestinálne ťažkosti pri CKD sú časté: uremická nauzea, zápcha pri obmedzení tekutín a fosfátových viazačoch, hnačka pri niektorých viazačoch, gastroparéza pri diabete, polyfarmácia. Ak obraz spĺňa DGBI a chýbajú alarmy, má zmysel neeskalovať CT a endoskopiu len preto, že pacient „už aj tak veľa chorôb má“. Ak je však prítomná anémia z nedostatku železa, krvácanie, neúmyselný úbytok hmotnosti alebo nočná hnačka, CKD tieto alarmy nevysvetľuje a došetrenie sa nedeleguje na „funkčnú“ nálepku.

Praktické zhrnutie

- DGBI vrátane IBS sú určené na **pozitívnu, symptómovú diagnózu** podľa kritérií Rome, nie na nekonečné vylučovanie.
- Znalosť kritérií **nestačí**: v štúdii testovalo úvodne 70 % medikov aj pri Rome IV–konzistentnom IBS bez alarmov a 53 % pokračovalo po normálnom laboratóriu.
- Varovné príznaky treba hľadať aktívne; nočná hnačka a zámena funkčného príznaku za alarm sú časté chyby.
- Cielené testy (najmä pri hnačkovom fenotype) ostávajú namieste; zobrazovanie a kolonoskopia bez indície nie.
- Pri CKD platí tá istá logika – s osobitnou pozornosťou voči anémii a krvácaniu, ktoré sa nesmú schovať za základné ochorenie obličiek.

Súvisiace články

- Neceliakálna citlivosť na pšenicu – kedy hnačkový fenotyp nie je IBS a prečo celiakálna sérológia patrí pred elimináciu gluténu.
- Occam alebo Hickam? – ako tlak na rýchlu a „úspornú“ diagnózu mení klinické uvažovanie v nefrológii.
- Strava a zdravie čreva – kde končí užitočná práca s črevom a kde začína nediagnostikovaná organická choroba.

Zdroje

Spracovaný zdroj: *Linares M, Grimaldi C, Palma N, Vintimilla B, Candal S, Estrella D, Saps M. Knowledge Does Not Translate Into Diagnostic Restraint: Application of Rome-Based IBS Diagnosis Among Medical Students in Latin America. Neurogastroenterology & Motility. 2026;38(5):e70335. doi: 10.1111/nmo.70335. PMID 42087489, PMCID PMC13145304. PubMed, plný text (OA).*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje, úplný autorský zoznam (7 mien, PubMed AuthorList CompleteYN=Y), veľkosť súboru, percentá a p-hodnota boli overené 3. septembra 2026 cez PubMed eutils, Crossref a otvorený plný text v Europe PMC (CC BY). Medscape správa je sekundárny žurnalistický zdroj; paywall sme neobchádzali. Autori Rome Foundation do mapy zdrojových autorov nepatria – sú citovaným rámcom, nie autormi spracovanej práce. Časť o cielenom testovaní vychádza z abstraktu ACG 2021 a verejných stránok Rome Foundation, nie zo študentskej vinety. Nefrologický most je vlastným odborným spracovaním; spracovaná štúdia obličkové ukazovatele nesledovala.*

1. **Linares M, Grimaldi C, Palma N, et al.** *Knowledge Does Not Translate Into Diagnostic Restraint: Application of Rome-Based IBS Diagnosis Among Medical Students in Latin America.* Neurogastroenterol Motil. 2026;38(5):e70335. PubMed.
2. **Medscape.** *Rome Criteria for IBS: When Is Further Testing Needed?* 2026. Sekundárne spravodajské spracovanie; individuálny autor nie je vo verejne dostupnom zobrazení spoľahlivo uvedený. Medscape.
3. **Rome Foundation.** *Rome V: A Global Framework for Disorders of Gut–Brain Interaction.* theromefoundation.org.
4. **Rome Foundation.** *Rome IV Criteria.* theromefoundation.org.
5. **Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, et al.** *ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome.* Am J Gastroenterol. 2021;116(1):17–44. doi: 10.14309/ajg.0000000000001036. PubMed.
6. **Begtrup LM, Engsbro AL, Kjeldsen J, et al.** *A Positive Diagnostic Strategy Is Noninferior to a Strategy of Exclusion for Patients With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial.* Clin Gastroenterol Hepatol. 2013;11(8):956–962.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2012.12.038. PubMed.
7. **Sperber AD, Bangdiwala SI, Drossman DA, et al.** *Worldwide Prevalence and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders, Results of Rome Foundation Global Study.* Gastroenterology. 2021;160(1):99–114.e3. doi: 10.1053/j.gastro.2020.04.014. PubMed.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=rome-kriteria-ibs-dgbi-dalsie-testovanie-medici · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.